

CAPÍTULO 8.14

Abdomen Agudo

PERFIL EUNACOM 1.06.1.006

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Patología Biliar

Marco Conceptual: Las 4 Entidades

TABLA 8.14.1: ENTIDAD VS SÍNTOMAS CLAVE

ENTIDAD	SÍNTOMAS CLAVE
Colelitiasis	Solo dolor (cólico biliar)
Colecistitis aguda	Dolor + fiebre
Coledocolitiasis	Dolor + ictericia
Colangitis aguda	Dolor + ictericia + fiebre (Tríada de Charcot)

1. Colelitiasis

Asintomática

- Hallazgo incidental en eco
- Conducta:** colecistectomía laparoscópica **electiva** (igual hay que operarla — riesgo de complicaciones futuras)

Sintomática — Cólico Biliar

- Clínica:** dolor sordo en epigastrio/hipocondrio derecho que dura 30–60 min y cede espontáneamente; vómitos
- Diagnóstico:** clínico + eco (confirma cálculos)
- Tratamiento agudo:** dipirona + butilbromuro de hioscina (antiespasmódico) + antiemético si vómitos
- Definitivo:** colecistectomía laparoscópica **electiva**

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Dipirona + papaverina (o hioscina) = tratamiento clásico del cólico biliar en EUNACOM.

2. Colecistitis Aguda

Clínica

- Dolor persistente (> 30 min) en hipocondrio derecho + fiebre
- Signo de Murphy (+):** dolor intenso al comprimir hipocondrio derecho con inspiración profunda
- Náuseas, vómitos, leucocitosis, PCR elevada

Ecografía (diagnóstico)

Buscar 3 signos específicos de colecistitis aguda:

- Barro biliar** (el más visible en imágenes de examen)
- Vesícula > 10 cm** (globosa)
- Pared vesicular > 4 mm** (engrosada)

Tratamiento

- Colecistectomía laparoscópica **de urgencia** (diferencia clave con colelitiasis)

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Única indicación de colecistectomía de urgencia = **colecistitis aguda**. Todo lo demás (colelitiasis asintomática, cólico biliar, colecistitis crónica) → cirugía **electiva**.

3. Coledocolitiasis

Clínica

- Dolor + **ictericia** (sin fiebre si no hay infección)
- Pruebas hepáticas: patrón colestásico (↑ FA y GGT)
- GGT elevada** = signo sensible de obstrucción de vía biliar extrahepática

Diagnóstico (secuencia)

- ...
- Eco abdominal (siempre primero)
- Dilatación de colédoco > 7 mm = sospecha coledocolitiasis
- A veces (raramente) ve el cálculo directamente
- ↓
- Colangio-RNM (CPRM)
- Examen de elección para confirmar: ve todos los cálculos
- ↓
- CPRE (colangiografía endoscópica retrógrada)
- Solo cuando ya sé que hay cálculo (confirmado por eco oolangio-RNM)
- Terapéutica: extrae el cálculo
- ...

¿Cuándo ir directo a CPRE sinolangio-RNM?

- Colangitis aguda (urgencia)
- Eco que ve el cálculo directamente en el colédoco

Tratamiento

- CPRE → extracción endoscópica del cálculo
- Después: colecistectomía laparoscópica **electiva** (tratar la causa de base)

4. Colangitis Aguda

Tríada de Charcot

Dolor + Ictericia + Fiebre — diagnóstico clínico

Péntada de Reynolds (forma grave)

Tríada de Charcot + **Compromiso de conciencia** + **Hipotensión arterial**

Tratamiento

- Suero fisiológico EV** (reponer volemia — hipotenso)
- CPRE urgente** (drenaje de vía biliar — lo más importante)
- Antibióticos** de amplio espectro: **Ceftriaxona + Metronidazol**

EUNACOM CRITERIOS

¿Cuándo se hace CPRE sin pasar porolangio-RNM? 1. Colangitis clínica comprobada (dolor + fiebre + ictericia) 2. Eco que ve el cálculo directamente 3. Colangio-RNM que ve el cálculo Si la eco solo muestra dilatación de vía biliar sin ver el cálculo → primeroolangio-RNM → CPRE.

5. Colecistitis Crónica

Formas

TABLA 8.14.2: TIPO VS CARACTERÍSTICAS

TIPO	CARACTERÍSTICAS
Vesícula en porcelana	Calcificaciones en la pared vesicular
Vesícula escleroatrófica	Vesícula fibrótica, pequeña, sin lumen

- **Ambas** son hallazgos en eco - **Ambas** tienen riesgo de **cáncer de vesícula** → conducta = colecistectomía laparoscópica **electiva**

Resumen Cirugía Urgente vs. Electiva

TABLA 8.14.3: SITUACIÓN VS TIPO DE CIRUGÍA	
SITUACIÓN	TIPO DE CIRUGÍA
Colelitiasis asintomática	Electiva
Cólico biliar (colelitiasis sintomática)	Electiva
Coledocolitiasis	CPRE → luego colecistectomía electiva
Colecistitis aguda	Urgente
Colangitis	CPRE urgente → colecistectomía electiva
Colecistitis crónica	Electiva

Imágenes Clave en Ecografía

TABLA 8.14.4: HALLAZGO VS DIAGNÓSTICO	
HALLAZGO	DIAGNÓSTICO
Cálculo con sombra acústica	Colelitiasis
Barro biliar + pared gruesa > 4 mm + vesícula > 10 cm	Colecistitis aguda
Colédoco dilatado > 7 mm	Coledocolitiasis (sospecha)
Calcificaciones en pared	Vesícula en porcelana

NOTA CLÍNICA

Solo la sospecha de cáncer justifica convertir una laparoscopia a laparotomía abierta. En todos los demás casos la vía laparoscópica es de elección.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Mujer de 48 años con antecedentes de cálculos biliares conocidos consulta por dolor cólico en hipocondrio derecho irradiado a dorso de 12 horas de evolución que no cede con analgésicos comunes, acompañado de náuseas y fiebre de 38.2 °C. Examen físico: dolor a la palpación en hipocondrio derecho con detención de la respiración profunda (Signo de Murphy positivo). Laboratorio: Leucocitos 14.200/mm³ con desviación izquierda."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Colecistitis Aguda Litiásica: inflamación e infección de la pared vesicular por impacto prolongado de un cálculo en el cístico. Criterios de Tokio: Signo de Murphy (+) + Fiebre/Leucocitosis + Ecografía abdominal con signos inflamatorios (cálculos, engrosamiento pared > 4 mm, líquido perivesicular, signo de Murphy ecográfico). Tratamiento: Hospitalización + Régimen cero + Hidratación EV + Analgesia (AINEs/Opioides) + Antibióticos EV (Ceftriaxona + Metronidazol) + Colecistectomía laparoscópica precoz (< 72 horas).

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Abdomen agudo: diagnóstico clínico; no todos quirúrgicos ni todos con antibióticos
- Apendicitis: dolor epigástrico que migra a FID → apendicectomía; mujer joven: descartar embarazo/ginecología
- Plastrón apendicular: masa en FID → TAC + antibióticos IV, NO cirugía en agudo
- Diverticulitis: >50 años, FII; TAC obligatorio; colonoscopia CONTRAINDICADA
- Hinchey I=antibióticos, II=drenaje+antibióticos, III-IV=Hartmann
- Cirugía de Hartmann: colon no preparado; colostomía temporal 3-6 meses
- ≥2 episodios de Hinchey I-II → cirugía electiva (resección + anastomosis primaria)
- Fístula colovesical: neumaturia + ITU recurrentes → cirugía

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ABDOMEN AGUDO)

PREGUNTA 1

Paciente de 60 años con dolor en fosa ilíaca izquierda, fiebre y signos peritoneales localizados. ¿Cuál examen está contraindicado?

- A) TAC de abdomen y pelvis
- B) Colonoscopia
- C) Ecografía abdominal
- D) Hemograma y PCR
- E) Radiografía de abdomen

PREGUNTA 2

Paciente con diverticulitis aguda. El TAC muestra un absceso pericólico de 3 cm sin peritonitis. ¿Cuál es la clasificación de Hinchey y el tratamiento?

- A) Hinchey I; antibióticos
- B) Hinchey II; drenaje + antibióticos
- C) Hinchey III; cirugía de Hartmann
- D) Hinchey IV; cirugía de Hartmann
- E) Hinchey I; cirugía electiva

PREGUNTA 3

Mujer de 25 años con dolor que migra a fosa ilíaca derecha y signos peritoneales. ¿Cuál es la primera conducta?

- A) Apendicectomía inmediata
- B) Test de embarazo y evaluación ginecológica
- C) TAC de abdomen
- D) Ecografía abdominal
- E) Antibióticos empíricos

RESUMEN: ABDOMEN AGUDO

Clase sobre abdomen agudo: diagnóstico clínico, no todos son quirúrgicos ni todos llevan antibióticos. Se revisan signos peritoneales (resistencia muscular, Bloomberg, Rovsing, Murphy, McBurney, abdomen en tabla). Apendicitis: clínica + cirugía. Plastrón apendicular: masa en FID, TAC, antibióticos IV (no cirugía en agudo). Diverticulitis aguda: apendicitis del lado izquierdo en >50 años. Clasificación de Hinchey: I=antibióticos, II=drenaje+antibióticos, III-IV=cirugía de Hartmann. Colonoscopia contraindicada en diverticulitis. Mujer joven con abdomen agudo: siempre descartar embarazo y patología ginecológica. Fístula colovesical: neumaturia + ITU recurrentes.